

제 3절 골반협착에 의한 난산

1. 정상 골반 구조

- 골성골반은 뼈로 이루어진 골반의 골격구조를 말하며 4개의 뼈로 이루어짐
- 구성
 - 1개의 천골, 1개의 미골, 좌우 2개의 무명골
 - 치골결합 1개, 천골-미골결합 1개, 천골-장골결합 2개

2. 골반 구조의 산과적 의미

- 골반분계선에 의해 가골반과 진골반이 나뉨

가골반	내장을 지지하는 역할, 산과적 중요성 적음	
진골반	산과적으로 중요	
	골반입구	천골갑각, 천골익, 골반분계선, 치골상선
	골반출구	치골결합, 치골궁, 좌골조면, 미골과 천골좌골인대
	진골반 내강	진골반내강은 비스듬하게 굽어진 원통형 산과적으로 중요 옆사다리꼴 모양 진골반 내 태아 선진부의 하강 정도를 알 수 있는 지표

3. 골반의 단면과 직경

1) 골반입구

- 뒤는 천골갑각과 천골익, 옆은 골반 분계선, 앞은 치골수평지와 치골결합으로 경계 이루어짐

- 전형적인 여성의 골반입구는 일반적으로 난형보다 원형에 가까움
- 골반입구의 면은 4개 직경으로 구성

전후경	진결합선 대개 11cm	- 천골갑각 ~ 치골결합 상연 사이 거리 - 해부학적 결합선
	산과적 결합선 대개 10.5cm	- 천골갑각~치골결합 후면 사이 최단거리 - 산과적으로 중요, 분만시 장애요인
	대각 결합경 대개 12.5cm	- 천골갑각 ~ 치골결합 후면 사이 거리 - 내진상 측정 가능 - 산과적 결합선은 내진상 측정할 수 없기에 대각결합경에서 1.5~2cm를 빼서 측정
횡경 13.5cm	- 산과적 결합선에 수직으로 양쪽 분계선을 잇는 가장 긴 선	
사경 13cm	- 골반 한쪽 천장연골 결합과 반대편 장치골융기를 잇는 선	



◀ 골반입구 (전후경 - 빨간색 110mm)
(횡경 - 파란색 135mm)
(사경 - 초록색 125mm)

2) 중골반

- 골반 입구와 출구의 중간 부위 (양측 좌골극이 지표)
- 폐쇄분만의 경우 이두의 진입 후 상당히 중요한 산과적 의미

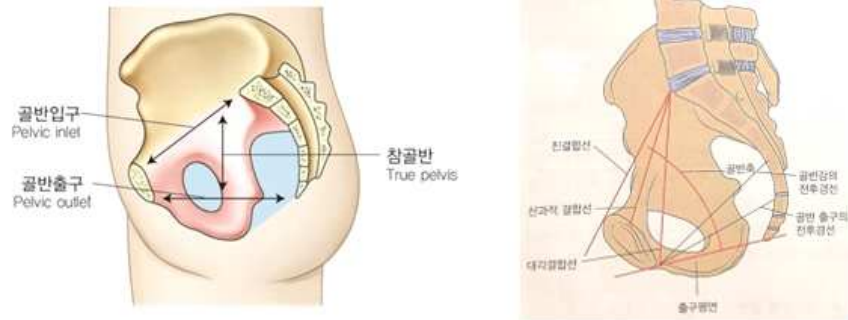
횡경	- 양측 좌골극 사이의 거리
----	-----------------

10cm	- 골반 내 직경 중 가장 짧음
전후경 11.5cm	- 치골결합 하단 ~ 좌골극간경을 수직으로 통과하는 연장선이 천골과 만나는 점까지의 거리 - 후시상경: 전후경이 좌골 극간경에서 나뉘진 뒷부분 에 해당

3) 골반출구

- 두 좌골조면을 잇는 선을 밑변으로 공유하는 두 개의 삼각형으로 구성 (뒤쪽의 삼각형의 첨단: 천골 끝 / 옆 경계: 천좌골 인대와 좌골조면)

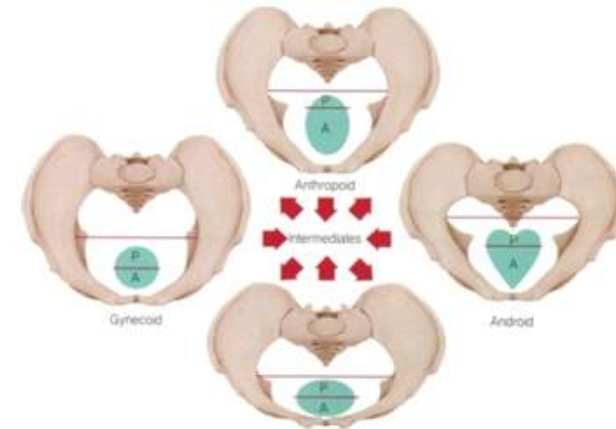
횡경	- 양측 좌골조면의 내연간의 거리
전후경	- 치골결합 하단 ~ 천골 끝까지의 거리 - 후시상경: 전후경의 뒷부분에 해당



4. 정상 골반의 형태

- 골반입구는 횡경에 의해서 전분절과 후분절로 나뉨
- 대부분의 골반은 순수형보다 혼합형
- 후분절의 특징에 의해 골반의 형, 전분절의 특징에 의해 경향이 결정

여성형 골반	- 정상골반, 다산형 골반, 입구 윤곽이 난형 or 원형 입구 횡경 $\geq$ 전후경, 전시상 $>$ 후시상 직경
남성형 골반	- 삼각형 골반, 난산이 심함 입구 횡경 $\geq$ 전후경, 전시상 $\geq$ 후시상 직경
유인형 골반	- 새장형 골반, 후시상경이 작음, 골반강 깊음, 난산 위험 높음 입구 전후경 $>$ 횡경
편평형 골반	- 골반강이 얇고 분만이 급속해 조절 어려움 - 골반강이 얇으면 분만이 빠른 경향 입구 횡경 $\geq$ 전후경
중간형 골반	- 혼합형 - 순수형에 비해 빈도가 훨씬 높다



▲(왼쪽부터 시계방향대로) 여성형 유인원형 남성형 편평형 ▲

#) 참고 부동고정위

- 아두의 시상봉합은 골반입구의 횡축을 따라 진입
- 이때 시상봉합이 모체의 치골결합과 천골갑각 사이의 정중앙을 통과 하려는 골반횡경에 일치하려는 경향이 있음.
- 실제로는 시상봉합이 천골갑각을 향해 뒤쪽으로, 또는 치골결합을 향해 앞쪽으로 치우쳐 있는 부동고정위가 흔함

5. 골반 협착

- 모든 형태의 골반협착에서 옥시토신 사용은 금기

1) 골반입구의 협착

1. 가장 짧은 전후경이 10.0cm 미만
2. 내골반 횡경이 12.0cm 미만
3. 대각결합경이 11.5cm 미만일 경우

-> 대각결합경은 산과적 진결합선보다 약 1.5cm 길기 때문

관련	태아의 태위와 태향	- 골반입구 협착은 비정상적 태위 발생에 중요 역할 - 두정위가 골반입구로 진입하지 못해 다른 태위로 변화 - 안면위/견갑위 발생 多, 제대탈출
	분만과정 중 이상	- 태아두부의 골반입구 진입을 방해할 정도로 골반협착 심한 경우 진통과정 진행 지연, 자연분만 X - 조기양막파수 & 경관개대 이상, 자궁파열, PROM 등
	태아에 미치는 영향	- 산류, 태아두부의 주형, 제대 탈출

		- 분만시 감염에 의한 태아 균혈증, 흡인성 폐렴
예후	① 전후경 < 9cm: 질식분만 거의 불가능 ② 9cm ≤ 전후경 < 10cm: 태위, 태아크기, 골반입구의 직경, 자궁수축빈도, 심한 부동고정위, 주형 등 여러 가지 요인에 의해 영향	
처치	C-sec 시행 (안전한 질식 분만이 불가능하다고 판단 시)	

2) 중골반의 협착

정의

- 전후경 < 11cm, 횡경 < 9cm, 횡경과 후방시상직경의 합 < 13.5cm

진단	내진 소견상 골반협착을 의심해야 하는 소견 : ① 양측 좌골극 돌출 ② 골반측벽이 모이는 형태 ③ 천골면 오목이 얇음
예후	아두의 횡정착의 원인이 됨 -> 겸자분만, 제왕절개 빈도 증가
처치	제왕절개술, 겸자분만, 진공만출술을 이용한 질식분만

3) 골반출구의 협착

정의

- 양측 좌골조면 간 직경이 8cm 미만

예후	- 대부분 중골반협착과 동반되어 난산의 원인 - 골반출구 협착 그 자체로는 난산의 원인 되는 경우 흔하지 않음
----	--

4절 생식기 연조직이상에 의한 난산

1. 외음의 이상

외음 폐쇄	외상이나 감염에 의한 유착 및 반흔에 의한 불완전 폐쇄가 빈번
외음 부종	정맥 혈전이나 혈종이 부종과 심한 통증 유발 -> 회음 절개 어렵게 함
외음 염증성 병변	1. 바르톨린 농양: 발견 즉시 처치 필요 2. 파르톨린 낭: 증상 없으면 분만 후 치료 3. 요도 게실, 낭 및 농양: 대부분 증상 X, 외과적 처치 필요치 않음
침형습우	분만 전 치료 -> 난산예방, 2차 감염 및 출혈 방지

2. 질의 이상

질중경 및 협착	1. 완전한 세로의 질중격 -> 분만시 난산 유발 X 2. 불완전 세로 질중격 -> 난산의 원인
질폐쇄	- 산도에 문제가 있으니 분만의 장애 요인
가트너관낭종	- 탈발광과 구별되어야 함 - 분만의 장애시 무균적 낭종 내용물의 흡인처리 필요

3. 자궁경부 이상

경부폐쇄 및 협착	원인	자궁경부소작술 or 난산에 의한 자궁경부 감염
-----------	----	---------------------------

	-> 자궁경부 반흔성 협착
	치료 대부분 정상분만 가능, 드물게 c-sec
자궁경부암	광범위한 침윤성 자궁경부암은 자궁수축시 자궁경관개대가 적절치 않아 난산을 일으킬 수 있음

4. 자궁전위의 이상

자궁전굴, 자궁후굴	자궁이 앞쪽이나 뒤쪽으로 꺾임
자궁의 소낭형성	- 오랜 염증성 질환, 자궁내막증, 자궁 내 유착치료 후 - 대개 분만 후 정상회복
자궁하수	- 시간경과하면서 회복되는 경우 많음 - 치료: 임신 초 피임기구 사용, 골반바닥이 지나치게 이완된 경우 임신 4개월 지날 때까지 횡와위 유지, 자궁경부가 질 밖으로 돌출된 경우 임신중절수술
염전(꼬임)	- 대부분 오른쪽으로 꼬임 - 염전되어 혈류 장애나 급성 복증이 일어나는 경우는 드물

5. 자궁평활근종

1) 임신과 자궁근종의 관계

임신 전	불임(에 밀접) 점막하근종
임신 중	1삼분기 유산 증가
	2삼분기 적색변성, 급속도로 성장
	3삼분기 난산, 태반조기박리

분만 시	출혈, 자궁무력증, 산도의 기계적 폐쇄
질식분만 후	후산기출혈(자궁이완), 자궁내막 감염

2) 적색변성

- 출혈성 경색에 의해 발생

증상	국소 동통, 압통, 미열
감별진단	충수염, 태반조기박리, 요관결석, 신우신염
치료	진통제 사용, 대부분 증상들은 수일 내 경감

3) 자궁경관근종

- 자궁경관, 하부절에 있는 자궁근종은 분만진행 막을 수 있음.
- 태아머리와 혼동 가능

자궁근종절제술

- ① 임신 전 자궁근종절제술의 기왕력이 있는 경우
 - 다음 임신에서 자궁파열 위험 높음 / 활성화 진통 시작 전 제왕절개로 분만
- ② 임신 중 자궁근종절제술
 - 임신 중에는 자궁근종절제술을 하지 않는게 좋음
 - 출혈 심해서 자궁적출을 해야할 수도 있기 때문
 - 전형적으로 자궁근종은 분만 후 현저하게 퇴축되므로 그 이후 실시

자궁근종과 임신경과 및 분만에 대한 관련성

- 임신 중 근종의 성장은 예측불가
- 요도압박하여 요저류, 배뇨곤란 유발
- 태반착상부위에 부착 또는 인접한 경우 태반조기박리, 유산, 조산

- 분만 후 근종부위 태반박리곤란, 감염, 자궁수축력미약으로 산후출혈 가능

6. 기타

자궁내막증	- 심하고 활동성인 내막증은 임신 중에는 드물 - 커진 골반 내 자궁내막증이 드물게 난산 일으킬 수 있지만 대부분 합병증없이 임신과 분만 가능	
자궁선근증	- 산과적, 외과적 문제점 X, but 합병증(ex. 자궁파열, 자궁외임신, 자궁이완, 전치태반) 발생 시 심각	
난소종양		- 임신 중 양성 난소종양 빈번히 발생 -> 영향 미미 - 악성 난소종양은 임신에 영향 줘서 염전, 경색증, 중증 합병증
	임신 중 합병증	염전, 경색증, 낭종파열, 질식분만 방해, 자궁파열
	치료	① 양성 -> 관찰 ② 악성 -> 의심시 즉시 수술 ③ 임신 말까지 진단 X -> 연기 ④ 분만방법 : 난소낭종이 골반에 끼지 않았다면 자연분만 후 낭종 치료 ⑤ 거대난소종양의 임신 중 치료 시기: 임신 4개월경

5절 난산

1. 개술 및 정의

- ① 임신 28주 이후에 임신부가 분만하는 과정 중 태아와 부속물이 순조롭게 만출되지 않는 것
- ② 태아가 오랫동안 만출되지 않으며, 분만 시 요복에 통증있고, 소복이 무겁고 빠지는 감이 있으며 胞水와 혈이 함께 흐르는 경우
- ③ 현대의학의 이상분만에 해당

2. 병인병기

- ① 임신부가 선천적으로 품부가 부족하거나 기혈이 허손되어 태아 만출하지 못함
- ② 임신부가 간경이 울결되고 기체어조해 태아를 만출하지 못함
- ③ 산도이상으로 交膈이 不開
- ④ 태아가 너무 큼
- ⑤ 태위부정

3. 진단과 감별진단

진단	- 임신 28주 이후 분만이 곤란한 상황을 확인 -> 골반의 형태 및 크기, 태아 발육상태, 태아와 산도 이상을 파악해 분만양식 결정
감별진단	- 초음파, 항문이나 질 검사로 명확하게 진단
	- 분만 전조증, 가진통

4. 변증치료

기허형	분만 시 자궁수축 비록 규칙적, 대칭성, 극성이나 연약하고 무력, 수축시간 짧고, 간혈시간 길다	
	대보원기	독삼탕, 최생여의산
혈허형	태막이 먼저 파열되거나 분만 전에 출혈이 있고 자궁 수축력이 미약하면 난산이 발생	
	양혈보기	채송정난산방, 보생무우산
기체형	정신적인 억울과 긴장, 흥민완창, 분만 시 요산복창 거안, 자궁수축이 강해도 극성, 대칭성	
	이기활혈 행체최생	서기산 합 최생음, 최생순기음

6절 포의불하

1. 개술

- 1) 정의: 태아가 만출 후 30분이 되어도 태반이 반출되지 않음
- 2) 병인병기
 - 임신부가 몸이 허약해 포의를 외부로 배출할 힘 X
 - 한사의 침습으로 기혈응체/어혈응체 -> 태반조체

2. 변증치료

- 1) 기허불운형 -> 보중익기탕 합 생화탕 (자궁수축 역할) / 가삼생화탕 (어혈 + 기체)
- 2) 한응혈체형 -> 흑신산 합 도홍사물탕
- 3) 패혈응체형 -> 탈명산 합 생화탕

제 7단원 산후병

0. 산욕기

- 분만으로 인한 상처가 완전히 낫고 자궁이 평상시 상태가 되며 각 기관이 임신 전 상태로 회복되기까지의 기간
- 대개 산후 6~12주
- 산욕기에 자주 쓰는게 생화탕.
- 인삼은 초기에만 살짝 써야 한다. 젖을 말리기 때문에 만삼(당삼)으로 대체하는 것이 바람직함.

1. 비뇨생식기의 복구

1) 자궁복구

만삭 시 자궁	약 1000g 정도
분만 직후	배꼽 아래로 내려감
분만 1주 후	50% 감소, 약 500g
분만 2주 후	골반 내로 들어올 정도로 작아짐
분만 4주경	퇴축 거의 완료, 약 100g
분만 6주경	거의 분만 전 크기 회복

자궁 크기 변화는 근육세포수의 감소가 아닌 크기 감소

2) 난소 크기/기능 회복

	비수유	수유
배란재개	평균 6주 이전 (27일에도 가능)	6개월
	# 분만 후 배란재개 시기는 모유수유 여부 따라	

	다름 +) 수유 횟수에 따른 배란 억제 효과도 다름 하루 한두 번 수유로 배란 억제 효과 미지수	
월경 재개	분만 12주 후 (70%) 분만 6~8주 후 (평균)	분만 후 2~18개월 이내
혈중 프로락틴	출산 3주 후 회복 # 모유 수유는 혈중 프로락틴을 증가시켜 분만 후 배란 억제	분만 6주까지 상승
혈중 에스트로겐	분만 후 바로 떨어짐 분만 2주 후부터 증가 17일 -> 수유군보다 높음	분만 후 바로 떨어지고 낮은 상태 유지
FSH	모유수유와 상관없이 같은 농도 유지 # PRL 증가 시 난소는 FSH에 반응이 없을 것	

3) 자궁내막 재생

① 스폰지층: 태반과 융모막 분리

② 기저탈락막: 자궁 내 남아있다가 분만 2~3일에 2개 층으로 나뉨

- 표층: 괴사되어 산후 질분비물(오로)로 배출
- 아래층: 자궁내막선이 남아 새로운 자궁내막 생성
- 분만 7일 후 자궁내막표층은 상피로 덮이고 16일에 증식기 내막 형태

4) 태반 부착 부위

- 분만 전 18cm -> 분만 후 9cm -> 분만 2주 말 3~4cm
-> 이 부위의 자궁내막은 다른 부위에 비해 느리게 재생

- 태반부위 완전 퇴축에 6주 소요

5) 자궁 경부 회복

분만 직후	부드럽고 얇아지며 양 옆으로 벌어짐
분만 2~3일 후	자궁경부 입구 좁아짐 (2~3cm)
분만 1주일 후	임신 전과 비슷한 양상

조직학적 변화

- 4일 내 상피세포 퇴행, 일주일내 자궁경부내부종, 출혈 감소
- 임신 중 비대증식된 혈관은 지속되다 분만 6주경 임신전 상태로 회복
- 경부내 원형세포 침착과 부종은 3~4개월 정도 지속되기도 함

6) 융모생식샘자극호르몬(hCG) 변화

만삭 분만 후	급속한 감소 -> 이후 서서히 감소
평균 14일	혈중 내에서 완전히 사라짐
	# 자연유산 시에는 37일 소요 만삭분만은 태반 분리가 완전히 이루어지기에 짧음

7) 질과 탈출구

질 내경 넓이	점차 좁아지나 분만 전 상태로 회복되진 않음
질벽 내 주름	3주경 회복
자궁탈출 및 긴장성 발생 가능	질입구 늘어나고 골반지지구조물 변화에 의함

8) 요로계와 신장기능 변화

요관, 신우	- 임신 중 -> 확장 -> 주변혈관과 자궁크기증가로 인한 압박 및 P 영향 - 분만 후 -> 2~8주에 걸쳐 회복
방광	- 분만 후 -> 수용량 증가 -> 과도하게 늘어나고 완전히 배설되지 않아 잔류량 많아짐 - 신생아 머리 주위 둘레, 회음절개 유무와 관련 없음
요실금 발생	- 분만 시 요도 주변 근육 손상으로 인해 발생 - 진통 제 2기의 길이, 신생아 머리 주위 둘레, 신생아체중, 회음절개 유무와 관련 - 분만 후 1년 후에도 요실금 시 -> 50% 이상에서 증상 지속 - 제왕절개보다 질식분만 시 증가 - 50세 이상에서는 분만 경로에 따른 빈도 차이 X

9) 복막과 복벽의 변화

광인대 / 원인대	비임신보다 이완, 회복에 오래 걸림
분만 후 복벽	피부탄력섬유의 파열과 임신 시 커진 자궁에 의해 부드럽고 이완
	은선 제외 복벽은 정상 회복 but 복근 이완될 경우 여전히 느슨

2. 수유

1) 초유

- 출산 후 첫 24시간 내 100ml 미만

- 4-5일 이후 하루 500-750ml로 증가
- 분만 후 2일째부터 약 5일간 지속. 4주 동안 점차 성숙유로 전환
- 함유물질: IgA, 보체, 대식세포, 락토페린, 리소좀 등 (노란색)
- 단백질, 무기질은 초유가 많고 당분, 지방은 유즙이 많음

2) 유즙

- 수유하는 임신부는 1일 약 600ml의 유즙을 만들
- 보통 3시간에 한번씩 85ml 가량 수유
- 함유물질: 단백질, 인터루킨-6m B.T 림프구 거대세포, 표피성장인자, 락토즈
- 임신부의 나이가 많을수록 모유의 양이 줄어들
- 가슴의 크기와 모유의 양은 무관함

모유 수유가 태아에 미치는 장점

- 항감염효과
- 비감염성 질환(천식 습진, 임파종, 당뇨병, 비만) 감소
- 영아 돌연사 증후군, 비만증 적응
- 인지능력 발달 우수

모유 수유가 산모에 미치는 장점

- 수유 시 옥시토신 분비 -> 자궁수축 -> 산후출혈예방
- 수유 시 옥시토신 분비 -> 유선 주변 평활근 자극 -> 유즙 분출
- 배란 억제 -> 자연 피임효과
- 모성애 자극 -> 산후 우울증 감소
- 칼로리 활용 높아짐 -> 체중 감소

- 칼슘대사 촉진 -> 골다공증 발생 줄어듦
- 유방암 / 난소암 발생빈도 감소

3) 수유의 내분비학

- 유즙 분비량 및 기간은 반복되는 수유자극으로 조절
- 수유에는 체액성, 신경성 기전이 복합되어 작용
- 프로락틴, 코르티솔, 인슐린, 황체호르몬, E, hPL
-> 유선 및 유즙분비기관 성장 발달
- 쉬한증후군같이 뇌하수체 과사될 경우 유즙 분비 X
- P&E 급격히 감소 -> α-락토알부민 증가 -> 유즙 락토즈 증가

4) 유즙 분비 관계 호르몬

임신 중 변화	FSH, LH -> 프로락틴 분비 억제, 유즙분비 억제
분만 후 변화	E, P 감소 -> 프로락틴 대량 분비, 유즙분비

유즙분비에 관계있는 그 외 호르몬

- 옥시토신 -> 유즙분비 자극
- 평활근 수축 -> 유선압박 -> 유즙 나옴, 산후 자궁근 수축
- 에피네프린 -> 유즙분비 억제
-> 분노, 사려가 과하면 유즙분비 안되는 이유

5) 수유의 면역학적 영향

- 모유내 중요한 면역글로불린: IgA (항균작용)
- 모유 먹는 영아는 장염에 덜 걸리고 잘 이겨냄
- T림프구, B림프구, 거대세포 -> 영아 면역작용에 관여

3. 육아

- 모유 양이 처음에 부족하더라도 수유를 계속하면 적당해지지만, 유방 확대술 받은 임신부의 65%에서는 유즙분비장애 발생
- 수유로 유두 반복자극 -> 옥시토신 분비 촉진 -> 자궁수축 증가 -> 자궁퇴축 촉진
- 에어로빅 운동: 산욕기 6~8주에 시작, 1주에 4~5번할 시 수유에 별다른 영향을 주지 않고 임신부 심장혈관기능 좋아짐

1) 유즙분비 억제

경구피임약	모유량 감소 (금기는 아니지만 수유 결정 때까지는 시작 X)
P만 포함한 경구피임약	최소의 영향만 주기 때문에 유즙분비에 장애가 되지 않음
흡연	모유량 감소, 영아의 성장속도 감소

2) 모유 수유의 금기증

- HIV, 음주, 약물 남용, 갈락토스혈증아이, 치유받지 않는 활동성 결핵 산모, 유방암 치료 중 산모
- B형 간염은 수유 가능 (출생 24시간 내에 간염 면역 글로불린 백신 주사 후)

3) 유방과 유두의 처치

- ① 수유 전후에 유두 주위 청결 유지
- ② 유두가 과도하게 자극된 경우 -> 24시간 동안 수유 X

- ③ 유두 내번 또는 함몰된 경우 -> 임신 중 돌출되도록 마사지
- ④ 수유 원하지 않는 임신부 -> 냉찜질, 진통제 12-24시간 투여.
유즙 분비 억제 약물보다는 유방 탄력붕대 사용
- ⑤ 젖꼭지 균열 -> 세균감염의 입구로 작용
- ⑥ 남아 있는 유즙은 치료 지속 시에는 다 짜내주는 것이 좋음

4) 모유로 분비되는 약물

- 산모가 복용하는 대부분의 약물은 모유를 통해 분비
- 일반적으로 영아에게 흡수되는 약의 양은 적음
- 영향을 주는 요소: 약물의 혈중 농도, 약물과 결합하는 혈중 단백질 농도, 혈중 및 모유 산도 이온화 농도, 지용성 정도 및 분자량 등

MP ratio

: 복용한 약이 모유로 나가는 비율

- 수유모의 약물 섭취량의 최대 5%까지 아이에게 흡수 가능
- 보통 1%지만 산모와 영아의 체중 비율 생각 시 거의 1대1로 약물이 들어가는 것이니 주의
- 약물 이외에도 알코올, 카페인 등 다양한 것들이 흡수됨

5) 수유 시 금기 약물

- ① 남용약물로 사용금기인 약물: 암페타민, 코카인, 헤로인, 니코틴 등
- ② 방사능 포함 약물: 요오드, 소듐
- ③ 확실하지 않으나 영향을 미친다고 생각되는 약물: 항불안제, 항우울제, 항정신성 약물 등
- ④ 영아에게 현저한 영향을 미치므로 주의 필요한 약물

4. 산욕기의 임상적 측면

체온	- 유열: 분만 3~4일 후 유방종창에 의해 발생, 지속시간: ≤24시간, 생리적 - 산욕기 발열: 대개 감염으로 발생(비뇨생식기 감염 多) - 자궁의 간헐적 수축 -> 분만 3일 이후 악화 - 수유 시 옥시토신 분비 -> 통증 가중 - 혈관나 태반 조직, 이물질 등이 있으면 산후복통이 심함 - 산후복통: 분만 후 지속적 자궁수축으로 인한 통증 - 초산부: 분만 후 지속적 자궁수축으로 통증 덜 느낌 - 경산부: 주기적 자궁수축 -> 심한 통증 호소 (다산일수록) - 모유수유 중 심해짐(옥시토신 분비), 분만 후 3일에는 약해짐 -> 아니면 약을 사용	
산후통	- 분만 후 나오는 적혈구, 탈락막, 상피세포, 박테리아로 구성 - 출혈양상: 출혈 -> 적색으로 -> 장액성으로 -> 백색으로 - 지속기간: ① 1주: 태반부착부위의 혈류 증가 ② 6주 이상: 점차 사라짐 (생리적 증가) ③ 10주 이상 지속 시 이상 소견 - 처치: 옥시토신 등 자궁수축제 먼저 사용 -> 재발 시 소파술	
오로	- 정상임신 시 증가된 세포외액이 산후에는 이뇨작용에 의해 회복	
소변		

혈액	- 산욕기 첫 주에 상당량의 당 배설, 아세톤뇨 - 진통 시, 진통 후 -> 백혈구, 혈소판 증가 - 분만 전보다 혈색소, 혈구용적, 적혈구 수 감소 -> 임신부 상당 실혈	
	분만 1주	혈액량의 회복 (비임신 수준)
	분만 2주	심박출량의 회복 (분만 48주 정도까지 증가된 수준으로)
체중감소	유발요인	임신 중 체중 증가, 초산부, 조기 직장복귀, 흡연
	- 분만 6개월 후 평균 1.56~4.1kg의 임신 중 증가된 체중이 남아 있음 - 이를 예측할 수 있는 중요인자는 임신 중 체중증가	

5. 심혈관계와 혈액 응고 변화

혈장량	- 분만 직후 약 1000ml 정도 감소 - 전체 혈류량은 분만 전과 비교해 16% 감소
맥박	- 분만 후 30~60분 동안 빠른 상태
혈압	- 분만 후 4시간 동안 이완기 혈압 약 5% 증가
심박출량	- 임신 중 증가 - 분만 때 감소하기도 하나 1년 뒤 결과적으로 증가
혈소판 수치	- 분만 2주 후 모든 환자 증가
섬유소용해능	- 분만 1~4일에 증가 / 1주일 후 정상
혈액 응고성	- 분만 후 48시간 동안 최고치 - 섬유소원은 분만 후 2주에 걸쳐 감소 - 산욕기에는 혈전색전증 위험 증가 -> 산후 어혈 치료 필요 (ex. 생화탕)

생화탕

- 생화탕에서 어혈에 주로 작용하는 약제는 도인 하나
- 당귀 천궁이 많이 들어가는데 이는 자궁 수축을 강하게 촉진
-> 남아있는 것들을 배출해주는 의미
- 비통혈을 잘 시켜서 생화지원으로 인해 신혈을 더 잘 만들게 한다는 의미에서 생화탕이라 부름.

6. 산욕기의 모성 간호

진통 후의 처치	- 혈압, 맥박 -> 분만 후 2시간 동안 15분마다 주기적 측정 - 체온 -> 첫 8시간 동안 4시간에 한번 측정, 이후 8시간마다 측정 - 출혈량, 자궁 수축 여부 점검 - 이완되어 있을 시 복벽 통해 마사지
조기 보행의 장점	- 방광 장애, 변비 감소 / 정맥 혈전, 폐색전증 예방
회음부 처치	- 전방에서 후방으로 세척 (회음부에서 항문 쪽) - 회음부 통증 시 - 회음절개 후 통증이나 요도 주위 불편감으로 배뇨곤란 가능 - 심하면 회음부, 질, 직장 주위 혈종/감염 여부 확인 - 치질 탈출 시 스테로이드 포함 좌약, 국소마취스프레이, 연고 - 지속적 통증 호소 -> 좌욕

방광 기능	- 분만중/후 수액공급, 옥시토신(항이뇨) 중단 -> 급격 방광팽창 - 마취제, 절개, 혈종 -> 방광 감각 저하, 배뇨 능력 저하 - 분만 후 4시간 내 배뇨하지 못함 -> 멜라톤으로 HD
장 기능	- 분만 전 관장, 조기 보행, 일반식 권장 - 크게 문제되지 않음
산후 불편감	- 산후통, 회음절개, 열상, 유방 종창, 척추마취 후 두통
우울감	① 산후 우울감: 분만 후 며칠 내 일시적 우울감 대개 10일 이내 호전 -> 에스트로겐의 분만 후 급격한 저하로 인해 나타나거나 정서적 불안감, 수면 부족 등 ② 산후 우울증: 경증에서 자살까지 다양
복벽 이완	- 복대는 도움 X, 거들 사용이 좋음
식이	- 자연분만 후 마취하지 않는 이상 제한 X - 분만 후 적어도 3달 동안은 철분 보충 ① 수유부: 고칼로리 고단백 ② 비수유부: 일반인과 동일
성관계	- 분만 후 2주부터 가능 - 회음부 통증이 잦아들고 출혈 줄어들면 다시 시작 가능 - 지속적 성교통 있는 경우 회음부 통증 출혈 / 만성피로 확인 - 모유수유 중에는 여성호르몬 저하로 질 위축과

	건조가 일어나 질 분비물 감소
월경 / 배란 복구	① 수유 X: 분만 후 6~8주 내 회복 ② 수유 O: 매우 다양, 2~18개월 내 회복
산후 관리	① 퇴원 시기: 합병증 X 질식분만 -> 48시간 이내 합병증 X c-sec -> 96시간 이후 ② 피임법: 경구피임약이 효과적 자궁내장치는 3주 내 삽입해도 무방 ③ 직장 복귀: 분만 후 6주 정도면 가능